

Padova, 09/04/2026

Al Medico di Medicina Generale del Sig. Bulegato Ivano, nato il 03/05/1962.

e p.c. alla dott.ssa Ottaviano Giuseppina, UOC Otorinolaringoiatria (AOUP)

Egregio Collega, il Sig. Bulegato Ivano il giorno 11/03/26 è stato sottoposto a visita medica presso l'Ambulatorio di Medicina del Lavoro, con il seguente quesito diagnostico "Esposizione a polveri di legno in ITAC", di sospetta origine professionale.

## **ANAMNESI LAVORATIVA**

Il paziente riferisce di aver lavorato:

- dal 08/1980 al 12/1982 come aiuto meccanico presso la ditta Soravia Pietro, con sede a Marghera (VE), azienda operante nel settore della manutenzione di impianti industriali, con attività comprendenti, a titolo esemplificativo, la riparazione e manutenzione di motori elettrici e la sostituzione di valvole e componenti impiantistici.
- dal 05/1981 al 05/1982 ha svolto il servizio di leva militare, prima ha svolto il servizio di fanteria a Portogruaro (VE), poi ha ricoperto lo stesso ruolo ad Oderzo (TV).
- dal 06/1982 al 08/1987 per la ditta individuale "Scapello Sergio", situata a Spinea (VE), azienda familiare dello zio materno. La ditta si occupava principalmente di posa, levigatura e verniciatura di pavimenti in legno. I materiali maggiormente utilizzati erano legni di rovere, ulivo, wengé e abete.

L'attività lavorativa si svolgeva con modalità variabili in relazione alle specifiche richieste dei committenti. Le lavorazioni venivano effettuate prevalentemente presso le abitazioni dei clienti, mentre il tempo restante era dedicato alle attività svolte presso il laboratorio artigianale. Nella maggior parte dei casi, il paziente si occupava della posa di listoni di parquet già pretagliati ed acquistati da fornitori terzi, occupandosi dunque delle operazioni di taglio solo nella fase di rifinitura, al fine di garantire la copertura integrale di tondeggi e spigoli. Tali operazioni venivano eseguite mediante l'utilizzo di una sega manuale.

Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa il paziente riferisce che si occupava anche dell'incollaggio dei listoni di parquet. In un primo momento veniva effettuato mediante l'utilizzo di colla vinilica, mentre negli anni più recenti tramite colle bicomponenti, in particolare utili per l'incollaggio dei listoni su pavimentazioni preesistenti in marmo.

Successivamente alla posa, veniva avviata la fase di levigatura del pavimento. Il lavoratore riferisce di aver svolto tale lavorazione in posizione assisa, mediante l'impiego di una macchina levigatrice di dimensioni paragonabili a quelle di una lucidapavimenti motorizzata, utilizzata per la lavorazione della maggior parte della superficie del pavimento. La macchina era dotata di un sacco di raccolta delle polveri in tela, che permetteva la fuoriuscita di parte delle polveri prodotte attraverso i pori del tessuto. Per la lavorazione delle porzioni periferiche delle stanze e delle aree prossime ai bordi delle pareti, la levigatura veniva eseguita manualmente mediante una levigatrice orbitale portatile. Tale attività veniva svolta in posizione inginocchiata ed il paziente riferisce che, in questa seconda fase di lavorazione, l'esposizione alle polveri di legno risultava particolarmente intensa, in quanto le polveri prodotte dalla precedente fase di levigatura risultavano diffuse nell'ambiente e si depositavano nelle immediate vicinanze del volto del lavoratore.

La fase di verniciatura veniva effettuata mediante l'utilizzo di resine sintetiche bicomponenti; il lavoratore riferisce di non aver impiegato vernici a base acquosa. In particolare, indica l'utilizzo di vernice bicomponente standard con aggiunta di catalizzatore in proporzione approssimativa del 10%.

L'applicazione veniva eseguita manualmente tramite pennello, in posizione inginocchiata, senza impiego di compressori. Il ciclo di trattamento prevedeva l'applicazione di tre mani di vernice, con un tempo di asciugatura di circa 12 ore tra una fase e l'altra. Il lavoratore riferisce la presenza di un odore particolarmente intenso durante tali lavorazioni e la comparsa di fenomeni irritativi a carico degli occhi e delle vie respiratorie durante l'esposizione ai vapori dei prodotti utilizzati. Per ciascuna stanza la fase di verniciatura richiedeva mediamente dai 20 ai 30 minuti; generalmente venivano verniciate circa 3–4 stanze per ciascun intervento.

Tale attività veniva svolta con frequenza variabile, mediamente da 2 a 4 volte alla settimana, per una durata lavorativa media di circa 8 ore/die.

Nel periodo lavorativo in questione il paziente riferisce di non aver fatto uso di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie.

- dal 09/1987 ad oggi come dipendente presso la ditta S.P.A. SOC. UN. Centro Ital. Vigil. Inter. e Stradale C. presso la filiale di Venezia (VE).

Svolge attività lavorativa con la mansione di guardia giurata su turni diurni e notturni, con una durata variabile compresa tra 8 e 12 ore giornaliere, per circa 5 giorni alla settimana.

Il lavoratore riferisce di non essere stato direttamente adibito a lavorazioni comportanti esposizione a polveri di legno, tuttavia indica di aver operato, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2018, nelle industrie dell'area di Marghera (VE) nell'ambito di attività svolte per Fincantieri S.p.a, azienda operante nel settore della cantieristica navale. Nello svolgimento delle proprie mansioni, riferisce che l'attività di vigilanza richiedeva l'accesso all'interno di capannoni industriali, con una frequenza di circa 2-3 volte alla settimana. In una sola di tali occasioni indica che l'impianto risultava in piena attività lavorativa, con lavorazioni del legno finalizzate alla realizzazione degli arredi interni delle cabine navali.

I capannoni cui accedeva presentavano una superficie stimata di circa 1000 m<sup>2</sup>. Il tempo di permanenza all'interno degli stessi era mediamente di circa 15 minuti per ciascun accesso. Il lavoratore riferisce che l'ambiente risultava polveroso, durante tali accessi indica di non aver utilizzato dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie. Riferisce inoltre la presenza di un impianto di ventilazione generale degli ambienti, ma non di sistemi di aspirazione localizzata presso le singole postazioni di lavoro.

Attualmente in attività lavorativa.

Riferisce di essere stato regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria come da D.Lgs 81/2008, per cui porta in visione i più recenti giudizi di idoneità (08/05/2020, 15/11/2023 e 18/11/2023), i quali indicano l'esposizione ai seguenti rischi: Movimentazione Manuale dei

Carichi, Attrezzature munite di videoterminali, Microclima, Dipendenze (alcool dipendenza): Guida Mezzi Patente B, Posture, Lavoro notturno.

## **ANAMNESI FAMILIARE**

Madre di 86 anni, affetta da ipotiroidismo in tiroidite di Hashimoto.

Padre deceduto a 88 anni, per complicanze di neoplasia non meglio definita.

1 fratello deceduto a 60 anni, per leucemia.

## **ANAMNESI FISIOLOGICA**

Nato a termine da parto eutocico, regolare sviluppo psicofisico.

Titolo di studio: scuola professionale.

Ha svolto il servizio di leva nel 1981/1982.

Non ha figli. Riferisce dieta libera e varia, appetito e digestione regolari, alvo e diuresi nella norma, ritmo sonno-veglia conservato. Riferisce di camminare molto in occasione del turno lavorativo (anche 20 km per singolo turno). Ex fumatore da 3 mesi, ha fumato ca 10 sigarette al dì per 5 anni. Riferisce assunzione saltuaria di alcolici e 5 caffè al dì. Nega assunzione abituale di farmaci. Nega allergie note. Indica di aver raramente svolto lavori di hobbistica relativi alla lavorazione di legno ed affini in ambiente domestico.

## **ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA**

Nega interventi chirurgici precedenti. Nega patologie a carattere ereditario/autoimmune nel gentilizio correlate alla patologia in analisi.

Il paziente riferisce che i datori di lavoro presso i quali era impiegato nella ditta di posa e trattamento di pavimenti in legno sono deceduti per carcinoma polmonare, secondo quanto riportato dal lavoratore, tale patologia sarebbe stata verosimilmente correlata alla prolungata esposizione professionale alle esalazioni di vernici e prodotti utilizzati nelle fasi di trattamento e finitura dei pavimenti in legno.

Nega riconoscimento di invalidità civile.

Infortunio sul lavoro con scivolamento e frattura della spalla sinistra nel 2007, trattata in modo conservativo con apparecchio gessato.

Ipercolesterolemia borderline, sine terapia.

Indica di aver sofferto di sinusite nel periodo di leva, in sede frontale bilaterale, senza operazioni successive. Nega diagnosi di polipi nasali. Deviazione del setto nasale nota ed ipertrofia dei turbinati, con diagnosi nel 2025. Dal 2010 ad oggi, ha eseguito cicli di lavaggi nasali con Rinocross spray nasale su indicazione dello specialista Otorinolaringoiatra, nei periodi di maggiore sintomatologia rinitica (circa 20 giorni/anno nella stagione invernale).

## **ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA**

Riferisce, negli ultimi cinque anni, episodi ricorrenti di epistassi con facilità al sanguinamento nasale, associati alla produzione di muco nasale denso. Per tale sintomatologia riferisce di aver effettuato cicli di aerosolterapia, senza ottenere benefici significativi.

In occasione degli episodi emorragici indica inoltre di aver fatto ricorso all'utilizzo di tamponi nasali. Nello stesso periodo, indica insorgenza progressiva di iposmia.

Per tale sintomatologia, il paziente si è rivolto allo specialista ORL che, in base all'obiettività, ha consigliato di rivolgersi alle cure Ospedaliere di Padova.

A tal proposito, ha effettuato i seguenti accertamenti:

- in data 26/05/2025 ha effettuato una VISITA ORL SPECIALISTICA eseguita presso "Diagnostica Riviera SRL" di Mira (VE), che mostrava: *"...si reperta degenerazione del turbinato medio di sinistra che ha aspetto granuleggiante a tratti eroso con tracce di sanguinamento recente e secrezioni purulente..."*;
- in data 13/10/2025 ha effettuato una VISITA ORL SPECIALISTICA eseguita presso "Diagnostica Riviera SRL" di Mira (VE), che riportava: *"Si prende visione di RMN massiccio che evidenzia neoformazione che occupa la fossa nasale sinistra estendendosi fino alla coana, non più riconoscibili turbinato inferiore e medio a sinistra; si estende fino alle cellette etmoidali omolaterali: segni di ristagno sinusale nelle camera di sinistra..."*;
- in data 20/11/2025 si riporta esito dell'ESAME ISTOLOGICO n° PD25-I-59973, eseguito presso l'UOC Anatomia e istologia patologica dell'Azienda Ospedale

Università di Padova, che riportava: *“...frammenti di adenocarcinoma di tipo intestinale della mucosa sinonasale, di tipo colico, moderatamente differenziato sec. WHO, Immunofenotipo: citocheratina 20 + diffusa, CDX2 + nucleare diffusa, ...Her2 negativo”*;

- in data 20/01/2026 è stato ricoverato presso l'UOC di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale Università di Padova: nella stessa data del ricovero ha eseguito la TC DEL MASSICCIO FRONTALE E DELL'ENCEFALO CON M.D.C. che mostrava la nota lesione espansiva naso etmoidale sinistra con bulging del setto nasale e della parete mediale del seno mascellare sinistro.
- In data 21/01/2026, in corso di ricovero, è stato sottoposto ad INTERVENTO CHIRURGICO programmato di resezione endoscopica mediante craniectomia transnasale bilaterale e ricostruzione con tratto ileotibiale sx, seguito in data 22/01/2026 da una TC cranio-encefalo di controllo che evidenziava regolari esiti post-chirurgici;
- In data 24/01/2026 ed in data 26/01/2026 ha eseguito due videorinoscopie con riscontro di regolari esiti chirurgici di plastica durale, senza segni di liquorrea;
- in data 28/01/2026 il paziente è stato dimesso;
- in data 10/03/2026 ha effettuato una VISITA ONCOLOGICA presso l'U.O.C. di Radioterapia (AOUP), che evidenziava: *“...il caso è stato discusso in sede multidisciplinare (...) Alla luce dell'esito dell'esame istologico con conferma di ITAC G2 di tipo colico, dello stato dei margini di resezione che documentano “focolaio isolato” di carcinoma isolato a livello della lamina cribrosa/terminazioni nervi olfattivi e dello stadio di malattia pT3cN0, è stata posta indicazione a valutazione radioterapica per trattamento radiante”*.

## ESAME OBIETTIVO

Condizioni generali buone. Altezza 180 cm; peso 80 kg.

Torace: paziente eupnoico in AA, simmetrico, FVT normotrasmesso su TAP, basi mobili e simmetriche. MV presente e normoudibile su TAP, non rumori patologici.

Cuore: toni validi, ritmici, pause apparentemente libere. PAO 140/80 mmHg; FC 95 bpm.

Addome: piano, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda; non organomegalie apprezzabili. Peristalsi presente e valida.

## CONCLUSIONI

Il Sig. Bulegato Ivano, di anni 63, ha svolto attività lavorativa per un periodo complessivo di circa 5 anni (1982–1987) in qualità di operaio/artigiano, con mansioni di posa, levigatura e verniciatura di pavimenti in legno. Nel corso di tale attività il paziente risultava verosimilmente esposto a polveri di legno, nonché a solventi e prodotti vernicianti nelle fasi di finitura superficiale. L'attività è stata svolta in assenza di sorveglianza sanitaria.

I tumori naso sinusali (TuNS) sono neoplasie rare nella popolazione generale con un'incidenza di 1 su centomila persone e rappresentano meno dell'1% di tutti i tumori (Sjöstedt S, Jensen DH, Jakobsen KK, Grønhøj C, Geneser C, Karnov K, Specht L, Agander TK, von Buchwald C. *Incidence and survival in sinonasal carcinoma: a Danish population-based, nationwide study from 1980 to 2014. Acta Oncol.* 2018 Sep;57(9):1152-1158). A causa della bassa incidenza nella popolazione generale queste neoplasie sono considerate patologie sentinella di alcune esposizioni professionali a polvere di legno o di cuoio, che ne aumentano l'incidenza rispettivamente nei lavoratori del legno e negli addetti alla lavorazione dei pellami (Binazzi A, Ferrante P, Marinaccio A. *Occupational exposure and sinonasal cancer: a systematic review and meta-analysis. BMC Cancer.* 2015 Feb 13;15:49). Gli adenocarcinomi (AC) di tipo intestinale (ITAC) costituiscono poco meno del 4% dei TuNS, rappresentano il secondo adenocarcinoma per frequenza dopo il carcinoma adenoideocistico e sono strettamente correlati all'esposizione alle polveri di legno duro, le quali incrementano il rischio di svilupparli di 800-900 volte (Sklar EM, Pizarro JA. *Sinonasal intestinal-type adenocarcinoma involvement of the paranasal sinuses. AJNR Am J Neuroradiol.* 2003 Jun-Jul;24(6):1152-5. PMID: 12812944; PMCID: PMC8149027). Gli ITAC si sviluppano per il 40% nell'etmoide, per il 25% nelle cavità nasali e per il 20% nel seno mascellare. Nello specifico l'istotipo colonico, così definito da Barnes, rappresenta la forma più frequente tra gli ITAC, costituendone il 40% del totale (Leivo I. *Sinonasal Adenocarcinoma: Update on Classification, Immunophenotype and Molecular Features. Head Neck Pathol.* 2016 Mar;10(1):68-74. doi: 10.1007/s12105-016-0694-9. Epub 2016 Feb 1. PMID: 26830399; PMCID: PMC4746143).

Nel caso del Sig. Bulegato riteniamo l'intensità e la durata dell'esposizione alla polvere di legno, nonché la cronologia di comparsa compatibili con l'eziologia professionale.

Concludiamo pertanto con la seguente diagnosi:

“Adenocarcinoma di tipo intestinale della fossa nasale sinistra, compatibile con l'origine professionale”.

Per tale patologia abbiamo compilato il Primo Certificato di Malattia professionale, che consegniamo al paziente.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo cordiali saluti.

Il Medico in Formazione Specialistica, Dr. Federico Favaro

Il Medico in Formazione Specialistica, Dr.ssa Silvia Rossetto

Il Dirigente Medico dell'Ambulatorio di Medicina del Lavoro, Dr. Filippo Liviero